

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE WARFARINA

CON PUENTE DE ENOXAPARINA

Uso individual – completar según fecha operatoria, dosis y criterio médico

Paciente:		Médico:	
DNI:		INR previo:	
Procedimiento:		Riesgo trombótico:	Bajo / Intermedio / Alto ▼
Fecha de cirugía:		Observaciones:	

PLAN DE SUSPENSIÓN, PUENTE Y REINICIO

Día -6	Día -5	Día -4	Día -3	Día -2	Día -1	Día 0	Día +1	Día +2 a +4	Día +5 o según INR
									
Evaluación inicial	Suspender warfarina	Sin warfarina	Sin warfarina	Enoxaparina (sc)	Última dosis de enoxaparina	Cirugía / Quirófano	Reiniciar enoxaparina (según hemostasia)	Continuar enoxaparina + warfarina	Suspender enoxaparina cuando INR terapéutico
- Controlar INR. - Evaluar riesgo trombótico y hemorrágico. - Planificar puente según indicación.	- Última dosis de warfarina. - No administrar más warfarina. - Controlar INR si se considera necesario.	- No administrar warfarina. - Puente con enoxaparina según INR y riesgo trombótico (habitualmente cuando INR < rango terapéutico).	- No administrar warfarina. - Continuar puente con enoxaparina según indicación.	Administrar enoxaparina terapéutica (1 mg/kg cada 12 h o 1,5 mg/kg cada 24 h) según protocolo e indicación.	- Última dosis 24 horas antes de cirugía (1 mg/kg c/12 h). - En procedimientos de alto riesgo hemorrágico, considerar 24 h.	- No administrar enoxaparina terapéutica. - Procedimiento según equipo tratante.	- Reiniciar 12–24 h post cirugía, según hemostasia y riesgo hemorrágico. - Dosis terapéutica o profiláctica según indicación.	- Reiniciar warfarina (dosis habitual). - Continuar enoxaparina hasta INR en rango terapéutico ($\geq 2,0$ por 2 mediciones).	- INR 2,0–3,0 (según indicación). - Suspender enoxaparina. - Continuar warfarina.
Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:

Dosis de enoxaparina (habituales)



Dosis terapéutica:

1 mg/kg cada 12 horas SC o 1,5 mg/kg cada 24 horas SC.

Dosis profiláctica (según indicación):

40 mg cada 24 horas SC.



Indicaciones de puente (ejemplos)



- Válvula mecánica (especialmente mitral).
- TVP/TEP reciente (< 3 meses).
- FA con alto riesgo de ACV (CHA₂DS₂-VASc alto).
- Trombofilia de alto riesgo.
- Otros según criterio clínico.



Consideraciones importantes

- Suspender warfarina al menos 5 días antes de la cirugía (puede requerir 6 días en algunos pacientes).
- El inicio del puente con enoxaparina depende del INR y del riesgo trombótico.
- Ajustar dosis según función renal, peso y riesgo hemorrágico.
- Controlar INR al reiniciar warfarina.
- Coordinar con equipo quirúrgico y anestesia.
- Individualizar la conducta según paciente.



Consultorio GHEMAS
Arrieta 1728,
Villa Luzuriaga



Consultorio Baruch
Agüero 1235,
Morón



Turnos / WhatsApp:
11 5403 0229



Fuentes y referencias

- CHEST. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2022;160(6):e545–e608.
- ASH. Guidelines on the Management of Anticoagulation Around Surgery. Blood Adv. 2022.
- SAH. Guía de Hemostasia y Trombosis. Sociedad Argentina de Hematología. 2023.

Adaptar siempre al paciente, al procedimiento y al criterio del equipo tratante.